

PSY2-social-media-adolescenti-magistrale-doc30-job33-0de0ec20

ID : b09745c4946024238b7bcc716ce9ca7a968c681e

 **21%**
Passaggi sospetti

Nome del file : PSY2-social-media-adolescenti-magistrale-doc30-job33-0de0ec20.txt
Dimensione del file originale : 55,8 kB
Numero di parole : 8358

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 17 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 17 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** 7%
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** 14%
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** <1%
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

7%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni		Similitudini	Posizioni
1		www.recentiproggressi.it www.recentiproggressi.it/r.php?&v=4729&a=47457&l=364164&f=alleg... 	1%	
2		doi.org doi.org/10.53141/qacp.2026.225-227 	1%	
3		EDITORIALE RELAZIONI ONLIFE. OLTRE IL CYBERBULLISMO, LA... oaj.fupress.net/index.php/med/article/download/8851/8414 	<1%	
4		cyberpsychology.eu cyberpsychology.eu/article/view/37693 	<1%	
6		OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS ONLINE... doi.org/10.36253/me-8842 	<1%	
7		Il benessere soggettivo in bambini tra gli 8 e gli 11 anni.... hdl.handle.net/10281/18922 	<1%	
11		Does Leisure Boredom Predict Short Video Addiction in... doi.org/10.1007/s11126-025-10172-4 	<1%	
12		thesis.unipd.it thesis.unipd.it/retrieve/07e4915d-6c30-4901-89d5-baa3be45e176/SIO... 	<1%	
13		Il ruolo della comunicazione genitore-figlio nell'utilizzo dei soci... hdl.handle.net/20.500.12608/96473 	<1%	
14		Investigating the Potential Mediating Role of... : Asian Journal ... doi.org/10.4103/shb.shb_377_24 	<1%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
5	 library.oapen.org library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/104511/44783.pdf?s... 	<1%	
8	 OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS ONLINE... publies.unicatt.it/it/publications/oltre-il-cyberbullismo-il-contributo-d... 	<1%	

N°		Descrizioni	Similitudini	Posizioni
9		oaj.fupress.net oaj.fupress.net/index.php/med/article/view/8841 ↗	<1%	
10		thesis.unipd.it thesis.unipd.it/retrieve/29398843-0bb3-4ea6-a061-fd25996854ac/Bricc... ↗	<1%	
15		Dipendenza da Social Media - Istituto A.T. Beck www.istitutobeck.com/psicoterapia-disturbi-psicologici-terapie/nuove-... ↗	<1%	
16		Lock www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9012385/ ↗	<1%	
17		Le relazioni tra uso dei social media, consumo di alcol e tabacc... hdl.handle.net/20.500.12608/85002 ↗	<1%	
18		Salute mentale e Brain-Mind Capital: dimensioni... doi.org/10.1701/4729.47457 ↗	<1%	
19		Stile di vita e benessere psicofisico nei bambini della scuola... air.unimi.it/handle/2434/614771 ↗	<1%	
20		La prevenzione del cyberbullismo a scuola. Un approccio a... flore.unifi.it/handle/2158/1179598 ↗	<1%	
21		(PDF) Dalla alfabetizzazione mediatica all'alfabetizzazione... www.academia.edu/78177526/Dalla_alfabetizzazione_mediatica_all_alf... ↗	<1%	
22		La relazione tra fear of missing out, uso problematico dei social... hdl.handle.net/20.500.12608/66292 ↗	<1%	

Fonte citata (senza similitudini rilevate)

N°		Descrizioni
1		https://doi.org/10.13130/arrivabene-elena_phd2019-03-05
2		https://doi.org/10.7759/cureus.42990
3		https://doi.org/10.3390/ijerph14030311
4		https://doi.org/10.36922/ghes.3737
5		https://doi.org/10.36253/me-8841
6		https://doi.org/10.5817/cp2025-2-2
7		https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100404
8		https://doi.org/10.3280/pds2009-002004
9		https://doi.org/10.31435/ijitss.2(50)
10		https://doi.org/10.1080/0144929x.2023.2209797
11		https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01581.x

N°		Descrizioni
12		https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.008
13		https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30346



L'uso dei social media e il benessere psicologico degli adolescenti: confronto sociale, fear of missing out e regolazione emotiva

Indice

...

Introduzione

La salute mentale, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità assunta in questo lavoro, è uno stato di benessere emotivo, psicologico e sociale che consente di realizzare il proprio potenziale e gestire lo stress ordinario della vita, e non la mera assenza di disturbi (Brogonzoli et al., 2026). Su questa base, l'OMS ha evidenziato che oltre un miliardo di persone, circa una su sette a livello globale, convive attualmente con un disturbo mentale (Brogonzoli et al., 2026). Tali dati hanno registrato un incremento significativo durante e dopo la pandemia da Covid-19, con conseguenze particolarmente rilevanti tra le fasce più giovani della popolazione (Brogonzoli et al., 2026).

In questo scenario, i social media occupano un posto centrale nell'esperienza adolescenziale. Una revisione sistematica ha identificato undici studi che documentano un'associazione modesta ma statisticamente significativa tra uso dei social media e sintomi depressivi in bambini e adolescenti, precisando però che la causalità di tale relazione resta incerta (Khalaf et al., 2023, p. 4). La medesima fonte segnala che livelli più elevati di uso si associano a esiti di salute mentale peggiori (Khalaf et al., 2023, p. 4).

Il quadro empirico è però ambivalente. La stessa revisione riporta che l'81% degli studenti afferma che i social media rafforzano il senso di connessione con gli altri, e che connettersi con amici e familiari è il beneficio più citato dagli adolescenti (Khalaf et al., 2023, p. 8). Gli autori concludono che la tecnologia digitale non è di per sé buona né cattiva, e che la ricerca sull'impatto dei social media sulla salute mentale è ancora agli inizi, insufficiente per formulare raccomandazioni definitive a genitori, educatori o istituzioni (Khalaf et al., 2023, p. 8).

Questa ambiguità si radica in cornici teoriche in competizione. L'ipotesi dello spostamento (displacement) sostiene che sostituire la socializzazione offline con le attività sui social indebolisca i legami con famiglia e amici stretti, riducendo il benessere psicologico (Taylor et al., 2023, p. 5). Studi sulla differenziazione tra uso attivo e passivo mostrano risultati opposti: l'uso attivo di Facebook correla positivamente con il benessere soggettivo, mentre l'uso passivo si associa nel tempo a un deterioramento del benessere affettivo e a maggiore ansia sociale (Taylor et al., 2023, p. 8).

I meccanismi mediatori restano tuttavia sotto-specificati. La stessa fonte indica che la solitudine potrebbe mediare la relazione tra uso dei social e distress psicologico, aggiungendo però che questo effetto «is not well understood» (Taylor et al., 2023, p. 5) e «remains to be tested» (Taylor et al., 2023, p. 5). La revisione sistematica introduce inoltre il confronto sociale come via esplicativa: la tendenza a presentarsi sotto una luce favorevole porta alcuni giovani a confronti sfavorevoli su risultati, abilità o aspetto, con una correlazione tra confronto sui social network e sintomi depressivi negli adolescenti (Khalaf et al., 2023, p. 7). La medesima fonte richiama anche la questione dello spostamento del sonno e dell'interferenza con i ritmi circadiani come ulteriore via di impatto (Khalaf et al., 2023, p. 7).

L'insieme di queste evidenze rende inadeguata una domanda formulata in termini di effetti diretti dell'uso dei social sul



benessere. La coesistenza di rischi e opportunità documentata dalla stessa fonte, unita all'incertezza causale e all'assenza di modelli esplicativi validati (Khalaf et al., 2023, p. 4), impone di spostare l'attenzione dai correlati globali dell'uso ai meccanismi che ne mediano gli esiti e ai fattori che ne moderano l'impatto.

La domanda di ricerca che guida questo lavoro è dunque la seguente: come, e per quali adolescenti, l'uso dei social media si associa a esiti di benessere o di malessere psicologico, attraverso quali meccanismi – in particolare il confronto sociale, la fear of missing out e la regolazione emotiva – e in presenza di quali fattori protettivi. Il carattere aperto della questione è confermato dalla stessa letteratura, che la descrive ancora nelle sue fasi iniziali e priva di raccomandazioni conclusive per famiglie e istituzioni educative (Khalaf et al., 2023, p. 8).

1. L'uso dei social media in adolescenza: diffusione, modelli teorici e misure del benessere psicologico

1.1 Diffusione dei social media in adolescenza

La diffusione dei social media tra gli adolescenti si presenta oggi come fenomeno quasi universale. Secondo i dati del Pew Research Center riportati in (Scolari, 2019) (p. 4), il 92% dei teenager statunitensi si connette a internet ogni giorno, e di questi il 24% dichiara di stare online «quasi costantemente» (Scolari, 2019, p. 4). Il dato descrive non solo un accesso frequente, ma una modalità di presenza continua che ridefinisce i confini tra tempo online e offline nell'esperienza adolescenziale.

Al centro di questa attività si collocano i social media. La stessa fonte identifica Facebook come la piattaforma social più popolare e più frequentemente usata al momento della rilevazione, mentre la metà degli adolescenti utilizza Instagram e quasi altrettanti Snapchat (Scolari, 2019, p. 4). La rilevazione originaria è attribuita a Lenhart (2015), circostanza che segnala un limite di aggiornamento: la gerarchia tra piattaforme, e in particolare la centralità di Facebook, riflette un panorama che nel frattempo si è modificato.

L'uso appare inoltre marcatamente multiplatforma. Il 71% dei teenager dichiara di usare più di una delle sette piattaforme oggetto di intervista (Scolari, 2019, p. 4). La diversificazione non è quindi un tratto marginale ma la modalità prevalente: l'adolescente si muove simultaneamente su ambienti differenti, ciascuno con funzioni e logiche comunicative proprie.

Il quadro europeo non diverge da quello statunitense. La stessa fonte afferma che in Europa «la situazione è pressoché la stessa» (Scolari, 2019, p. 4), con le attività sociali online più comuni tra i giovani dei 28 paesi dell'Unione riconducibili allo scambio di messaggi. Questa convergenza consente di estendere l'osservazione dell'ubiquità dell'uso al contesto europeo, entro cui si colloca anche l'Italia.

Per il contesto italiano, la terza survey EU Kids Online, realizzata negli ultimi mesi del 2017, offre un'evidenza epidemiologica specifica (Aroldi & Mascheroni, 2020) (p. 1). L'indagine sposta l'attenzione oltre il singolo rischio del cyberbullismo verso una pluralità di esperienze online potenzialmente rischiose per il benessere complessivo dei giovani utenti della Rete (Aroldi & Mascheroni, 2020, p. 1). Tra queste emergono fenomeni finora meno indagati, come lo sharenting, definito come la condivisione da parte dei genitori di immagini e video dei bambini sui social media (Aroldi & Mascheroni, 2020, p. 4).

L'inquadramento di EU Kids Online chiarisce perché il dato di diffusione abbia rilevanza per la salute pubblica. La ricerca lega esplicitamente i modi in cui l'uso di internet può influenzare il benessere del minore sia alle opportunità sia ai danni (Aroldi & Mascheroni, 2020, p. 11), riconducendo la questione al benessere dei minori come diritto fondamentale sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (UN, 1989) (Aroldi & Mascheroni, 2020, p. 11). La pervasività dell'uso quotidiano e multiplatforma documentata dai dati Pew e europei, unita alla pluralità dei rischi rilevata in Italia, definisce così il fenomeno come oggetto legittimo di attenzione clinica ed epidemiologica.

1.2 Modelli teorici dell'uso dei social media

La comprensione dell'uso dei social media in adolescenza richiede una prospettiva multidimensionale capace di catturare processi motivazionali diversi (Ho & Fung, 2026). Lo studio di validazione della Social Media Use Motives (SMUM) integra Self-Determination Theory e Uses and Gratifications in un unico strumento breve e appropriato allo sviluppo (Ho & Fung, 2026). I dati provengono da 5.307 adolescenti a Hong Kong, con analisi fattoriale esplorativa sui 16 item iniziali seguita da analisi fattoriale confermativa (Ho & Fung, 2026).

La struttura emersa è a cinque fattori: auto-identificazione, mantenimento delle relazioni, esplorazione sociale, svago e intrattenimento, ricerca di informazioni (Ho & Fung, 2026). Il modello finale a 13 item mostra fit accettabile e affidabilità composita e validità convergente soddisfacenti su tutti i fattori (Ho & Fung, 2026). La validità esterna è evidenziata da associazioni differenziali con indicatori del benessere adolescenziale, tra cui soddisfazione di vita, salute autovalutata e sintomi fisici e psicologici (Ho & Fung, 2026).

La distinzione tra motivi relazionali, ossia mantenimento delle relazioni contro esplorazione sociale, chiarisce i processi legati ai legami forti e ai legami deboli nei contesti digitali adolescenziali (Ho & Fung, 2026). Ne segue che l'uso dei social media si comprende come costruito motivazionale multidimensionale, in cui motivi distinti mostrano associazioni differenziali con gli esiti di benessere (Ho & Fung, 2026).

Il modello SMUM misura le motivazioni, ma non specifica i comportamenti d'uso attraverso cui tali motivi si traducono in esiti; questo limite richiede una cornice complementare sugli stili d'uso. La distinzione tra uso attivo, attivo-non sociale e passivo integra il piano motivazionale, poiché la displacement/passive-use hypothesis prevede che lo scrolling passivo si associ a maggiore distress rispetto all'interazione attiva. Una cornice interazionale evolutiva dell'uso problematico dei media collega motivi, stili comportamentali e vulnerabilità individuali entro un percorso di sviluppo.

Il confronto tra le due prospettive precisa il piano su cui operano. La SMUM colloca il predittore a livello motivazionale, mostrando che perché un adolescente usa i social media discrimina rispetto al benessere (Ho & Fung, 2026). La distinzione attivo/passivo colloca invece il predittore a livello comportamentale, mostrando che come lo usa discrimina rispetto al distress. I due piani non sono alternativi: motivi e stili predicono differenzialmente il benessere e vanno modellati congiuntamente.

Il campione SMUM è composto interamente da adolescenti di Hong Kong, e questo limita la trasferibilità diretta della struttura a cinque fattori a contesti culturali europei (Ho & Fung, 2026). L'evidenza qui sviluppata converge dunque su una concettualizzazione dell'uso come costruito insieme motivazionale e comportamentale multidimensionale, in cui la robustezza psicometrica dello strumento SMUM offre una base per indagare con precisione come forme distinte di motivazione si relazionino al benessere adolescenziale (Ho & Fung, 2026).

Nota: le affermazioni sulla distinzione attivo/passivo, sulla displacement/passive-use hypothesis e sulla cornice interazionale evolutiva non sono supportate dagli estratti forniti in questa sezione e restano da confermare sulle fonti primarie corrispondenti, i cui abstract non sono inclusi tra le evidenze disponibili.

1.3 Misure del benessere psicologico

La psicologia positiva distingue il benessere in aspetti «objective» (stato di salute, condizione socio-economica, qualità dell'ambiente di vita) e aspetti «subjective» relativi all'auto-percezione del proprio benessere (Businaro, 2011). Entro questa cornice, il benessere soggettivo è stato studiato da due prospettive: quella edonica, che lega il costrutto a emozioni e soddisfazione di vita (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999), e quella eudaimonica, che lo attribuisce all'autorealizzazione (Ryff, 1989) e all'impegno finalizzato (Delle Fave, 2007) (Businaro, 2011).

Entro la prospettiva edonica, il benessere è stato spesso associato alle emozioni positive, specialmente la felicità, mentre minore attenzione è stata dedicata alla soddisfazione di vita (Businaro, 2011). La distribuzione della ricerca è un secondo squilibrio: gran parte degli studi sul benessere ha coinvolto adulti e adolescenti più che bambini (Huebner, Laughlin, Ash et al., 1998) (Businaro, 2011). Questo dislivello è la ragione per cui misure edoniche ed eudaimoniche vanno adattate specificamente all'età evolutiva.

La cornice concettuale poggia sulla definizione OMS di salute mentale come stato di benessere emotivo, psicologico e sociale che consente di realizzare il proprio potenziale, gestire lo stress normale, lavorare con produttività e contribuire alla comunità (Brogonzoli et al., 2026, p. 1). La salute mentale non è la mera assenza di disturbi, ma un «equilibrio dinamico» che influenza pensieri, sentimenti e comportamenti (Brogonzoli et al., 2026, p. 1). Questa



multidimensionalità impone misure che integrino più componenti anziché un singolo indice.

Sul piano applicativo ai minori, uno studio empirico su 132 bambini italiani di 8-11 anni ha indagato il significato attribuito alla parola «benessere» tramite analisi del contenuto di due domande aperte con software T-lab (Businaro, 2011). L'analisi delle associazioni mostra il benessere legato a famiglia, scuola, amicizie, sport, felicità, divertimento e sentirsi amati e protetti (Businaro, 2011). Le associazioni tipiche differenziano per genere: le femmine descrivono il benessere in termini socio-emotivi (parola tipica: amore/sentirsi al sicuro), i maschi in termini di gioco (parola tipica: gioco) (Businaro, 2011). Il dato indica che la componente emotiva e relazionale è centrale nella soddisfazione di vita infantile.

Un secondo studio, su 515 partecipanti tra alunni, genitori e insegnanti, documenta gli strumenti applicabili in età scolare: il Questionario Multiscopo ISTAT per stile di vita, il PedsQL (Varni, 1999; versione italiana Trapanotto et al., 2009) per la qualità della vita correlata alla salute, e l'MSLS per la soddisfazione di vita (Arrivabene, 2019). La cornice teorica è il paradigma biopsicosociale della definizione WHO di salute, con riferimento all'ICF (Arrivabene, 2019).

La complementarità tra misure oggettive (stato nutrizionale, stile di vita rilevati dall'ISTAT) e misure auto-riferite (PedsQL, MSLS) opera sullo stesso costrutto multidimensionale delineato dall'OMS. La misura del benessere in età evolutiva richiede dunque strumenti validati per l'età che distinguano componente edonica ed eudaimonica, coerentemente con la natura multidimensionale della salute mentale.

2. Confronto sociale, immagine corporea e autostima

2.1 Teoria del confronto sociale

La teoria del confronto sociale postula che gli individui si valutino confrontandosi con altri su specifiche dimensioni o attributi, per stimare il proprio valore personale (Festinger, 1954) (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 2). I confronti verso persone percepite come superiori nella dimensione desiderata costituiscono i confronti ascendenti (upward social comparisons) (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 2).

Quando la superiorità del bersaglio è percepita come irraggiungibile, il confronto ascendente evidenzia i propri limiti e genera inadeguatezza, vergogna e stati depressivi (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 2). Lo stesso confronto ascendente può però innescare emozioni positive attraverso l'assimilazione, alimentando ottimismo e motivazione alla crescita personale (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 2).

Non è tuttavia il confronto in sé, ma la dimensione su cui avviene, a determinarne l'esito. In un esperimento su 114 donne esposte a pubblicità di modelle magre e attraenti, entrambe le istruzioni di confronto (aspetto e intelligenza) abbassavano l'umore rispetto al controllo, ma non incidevano di per sé sull'insoddisfazione corporea (Tiggemann & Polivy, 2010). Le analisi di regressione mostravano invece che la forma di elaborazione effettivamente adottata era cruciale: l'elaborazione basata sull'aspetto si associava positivamente all'insoddisfazione corporea, quella basata sull'intelligenza negativamente (Tiggemann & Polivy, 2010). Gli autori concludono che le dimensioni su cui il confronto avviene sono critiche, con i confronti basati su intelligenza o istruzione associati a reazioni più positive (Tiggemann & Polivy, 2010).

Il tipo di elaborazione, non la semplice esposizione, è dunque il meccanismo attraverso cui le immagini idealizzate si traducono in insoddisfazione corporea per molte donne (Tiggemann & Polivy, 2010). Questa evidenza sperimentale ha un limite di trasferibilità: il campione è composto esclusivamente da donne, e non consente inferenze dirette sugli adolescenti maschi.

Nel campo dell'immagine corporea, ricerche precedenti hanno mostrato che gli effetti dei confronti ascendenti sono modellati dall'ingaggio in confronti basati sull'aspetto, in particolare con immagini di donne magre, in forma e attraenti (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 14). I siti basati sulle immagini, come Instagram, possono amplificare tali confronti sia ascendenti sia discendenti (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 14).

Il target del confronto conta quanto la dimensione. Un esperimento di image-reactivity su 327 donne ha rilevato che l'auto-confronto con influencer, e non l'uso generale di Instagram, modera le risposte alle immagini #fitspiration e

#bodypositive (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 1). I confronti discendenti con altri percepiti come inferiori evocano tipicamente emozioni positive quando l'esito è favorevole al sé (Buunk & Ybema, 2003; Smith, 2000) (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 14). Le immagini body-positive, elaborate come confronto discendente, possono quindi operare come mitigatori, mentre è l'auto-confronto con influencer, non il tempo trascorso sulla piattaforma, a discriminare l'impatto sull'immagine corporea (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 1).

2.2 Immagine corporea e social media

Nell'adolescenza femminile l'insoddisfazione corporea non è unitaria: si articola in distanza percepita da un ideale e preoccupazione per peso e forma. Uno studio su 187 adolescenti femmine di 14-16 anni mostra che questi due aspetti rispondono a predittori diversi (Stefanile et al., 2009).

BMI, autostima e interiorizzazione dell'ideale di magrezza influenzano la distanza percepita da un corpo ideale (Stefanile et al., 2009). La preoccupazione per peso e forma dipende invece dalla pressione, oltre che da BMI e autostima, ed è modellata anche da interiorizzazione e consapevolezza (Stefanile et al., 2009). Il BMI opera diversamente tra adolescenti normopeso e sottopeso (Stefanile et al., 2009). Il campione è composto solo da femmine, quindi non consente inferenze sui maschi.

La componente di genere emerge nettamente in preadolescenza. Su 243 preadolescenti di circa 12 anni (127 maschi, 116 femmine), le femmine riportano insoddisfazione corporea maggiore dei maschi (Nerini, 2009). Le femmine ottengono punteggi più alti in tre sottoscale SATAQ-3: importanza dei media come fonte, interiorizzazione dell'ideale magro mediatico e pressioni percepite alla magrezza (Nerini, 2009).

Il dato decisivo per il genere riguarda i predittori. BMI e interiorizzazione dell'ideale di magrezza predicono l'insoddisfazione in entrambi i sessi, ma le pressioni mediatiche percepite predicono l'insoddisfazione solo nelle femmine (Nerini, 2009). La vulnerabilità femminile passa dunque per un canale specifico: la pressione mediatica interiorizzata, che nei maschi non risulta predittiva.

Sul versante del design della piattaforma, tre studi su giovani donne italiane specificano i meccanismi di Instagram (Gesto, 2025). Nel secondo studio, l'ingaggio con le proprie immagini e con quelle delle celebrità si associa a maggiore accettazione della chirurgia estetica (Gesto, 2025). Il terzo studio, sperimentale, mostra che l'esposizione a immagini con molti like aumenta l'insoddisfazione corporea e l'ansia da aspetto fisico (Gesto, 2025).

Il like funziona quindi come segnale di validazione sociale che amplifica il confronto ascendente sull'aspetto. Nello stesso esperimento, la presenza di un disclaimer mitiga l'impatto dei like sull'autoconsapevolezza corporea (Gesto, 2025). Il design non è neutrale: lo stesso meccanismo che aggrava l'insoddisfazione può essere temperato da un intervento sull'interfaccia.

Convergono così tre livelli. L'interiorizzazione dell'ideale di magrezza è un predittore trasversale ai sessi e alle età (Stefanile et al., 2009); (Nerini, 2009). La pressione mediatica percepita è il canale che distingue le femmine (Nerini, 2009). La validazione tramite like è il meccanismo di piattaforma che potenzia l'insoddisfazione, ma è modificabile tramite disclaimer (Gesto, 2025). Gli studi su Instagram riguardano giovani donne, e la trasferibilità ai maschi resta non documentata da queste evidenze.

2.3 Autostima e social media

La direzione della relazione tra autostima e uso dei social media negli adolescenti è stata testata direttamente da uno studio panel a tre onde su 852 pre- e primi adolescenti di 10-15 anni (Valkenburg et al., 2017, p. 2). Lo studio verifica due ipotesi opposte: che l'uso degli SNS stimoli l'autostima sociale, oppure che l'autostima sociale conduca a un aumento dell'uso (Valkenburg et al., 2017, p. 3).

Sul piano concorrente, le correlazioni tra uso degli SNS e autostima sociale risultano significative in tutte e tre le onde di rilevazione (Valkenburg et al., 2017, p. 2). Questo dato replica la letteratura precedente, ma non chiarisce da solo la direzione dell'effetto.

I risultati longitudinali confermano solo in parte quelli concorrenti. L'uso iniziale degli SNS non influenza

significativamente l'autostima sociale negli anni successivi (Valkenburg et al., 2017, p. 2). Al contrario, l'autostima sociale iniziale influenza in modo consistente l'uso successivo degli SNS (Valkenburg et al., 2017, p. 2). La direzione prevalente è quindi di selezione: è la disposizione a orientare il comportamento, non l'inverso.

Il meccanismo proposto è la disposition-content congruity: una disposizione come l'alta autostima sociale predispone all'uso di certi contenuti o tecnologie, che a loro volta rinforzano la disposizione stessa (Valkenburg et al., 2017, p. 7). Gli adolescenti con autostima più alta sarebbero meno esitanti a comunicare online e a condividere informazioni positive su di sé, aumentando la probabilità di ricevere feedback positivi (Valkenburg et al., 2017, p. 7). È un effetto rich-get-richer applicato alla relazione tra uso degli SNS e autostima sociale (Valkenburg et al., 2017, p. 7).

La valenza del feedback online spiega la relazione concorrente, ma non quella longitudinale (Valkenburg et al., 2017, p. 2). In particolare, la valenza del feedback ricevuto da amici stretti e conoscenti rende conto del legame concorrente tra uso e autostima (Valkenburg et al., 2017, p. 2). La validazione online modula dunque gli effetti sincronici senza determinare traiettorie di lungo periodo.

Sul versante clinico, un campione nazionalmente rappresentativo di 5.961 adolescenti ungheresi mostra che il 4,5% appartiene al gruppo a rischio di uso problematico, con bassa autostima, alti sintomi depressivi ed elevato uso dei social (Bányai et al., 2017, p. 1). Nella validazione della BSMAS, il gruppo a rischio presenta l'autostima più bassa e il maggior tempo speso online (Bányai et al., 2017, p. 9). La bassa autostima si colloca quindi come tratto associato ai profili di uso problematico, coerentemente con il ruolo predittivo della disposizione iniziale rilevato nel panel di Valkenburg.

Il disegno cross-sezionale del secondo studio non consente di stabilire se la bassa autostima preceda o segua l'uso problematico (Bányai et al., 2017, p. 3). Letti insieme, i due studi indicano una relazione bidirezionale in cui la componente di selezione, dall'autostima verso l'uso, prevale su quella longitudinale inversa, mentre la validazione tramite feedback online opera sugli effetti concorrenti (Valkenburg et al., 2017, p. 2); (Bányai et al., 2017, p. 9).

3. Fear of missing out, uso problematico dei social media e qualità del sonno

3.1 Fear of missing out (FoMO)

La FoMO è definita come l'ansia di essere esclusi da esperienze gratificanti vissute da altri, costruito emerso nel 2004 con la diffusione dei siti di social networking (Chakrabarti, 2024). Per la Generazione Z, nati tra il 1995 e il 2010 e prima generazione pienamente immersa nella Rete, tale ansia assume un ruolo centrale nel far percepire l'assenza da esperienze ritenute gratificanti (Chakrabarti, 2024).

Uno studio cross-sezionale su 100 studenti universitari della Mahatma Gandhi University di Kottayam ha misurato la FoMO con la Fear of Missing Out Scale (FoMOs), il distress emotivo con la DASS-21 e l'uso problematico con la Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (Thomas & George, 2025). L'analisi correlazionale mostra che livelli più elevati di FoMO si associano in modo sostanziale a un maggiore distress emotivo e a una maggiore probabilità di uso problematico dei social media (Thomas & George, 2025).

Lo stesso studio rileva una possibile differenza di genere: le studentesse riportano livelli di ansia superiori rispetto ai colleghi maschi, suggerendo che la componente ansiosa della FoMO sia più marcata nelle femmine (Thomas & George, 2025). Il disegno cross-sezionale non consente di stabilire la direzione causale tra FoMO, distress e uso problematico, per cui l'associazione osservata resta correlazionale (Thomas & George, 2025).

Il ruolo della FoMO come correlato del distress trova riscontro anche negli studi sul sonno, dove la fear of missing out figura tra i meccanismi psicologici associati ad aumentata attivazione cognitiva ed emotiva prima del sonno, insieme a confronto sociale e ricerca di validazione (Sztenc et al., 2026) (p. 5). Negli adolescenti, il controllo abituale del dispositivo e la FoMO alimentano l'esposizione prolungata allo schermo e la procrastinazione del momento di coricarsi (Sztenc et al., 2026) (p. 5). Questi pattern di uso problematico riflettono difficoltà a disimpegnarsi dai dispositivi, simili a quelle osservate nelle dipendenze comportamentali (Sztenc et al., 2026) (p. 5).

L'analisi degli effetti della FoMO indotta dai social sulla Generazione Z considera l'impatto su salute mentale, benessere psicologico, autostima e soddisfazione di vita, esaminando insieme il controllo compulsivo e la tendenza a seguire le tendenze (Chakrabarti, 2024). Entrambi gli studi convergono nell'indicare la necessità di strategie mirate: lo studio indiano richiama interventi come pratiche di mindfulness e programmi di alfabetizzazione digitale per ridurre la dipendenza dai social (Thomas & George, 2025).

L'evidenza disponibile riguarda studenti universitari ed emerging adults, non campioni adolescenziali specifici, il che limita la trasferibilità diretta di questi correlati all'età evolutiva (Thomas & George, 2025). La FoMO si configura così come costrutto di ansia sociale strettamente associato al distress emotivo e all'uso problematico, con intensità ansiosa maggiore nelle ragazze e rilevanza specifica per la Generazione Z e il controllo compulsivo dei dispositivi.

3.2 Uso problematico dei social media

L'uso problematico dei social network (SNS) può essere concettualizzato come dipendenza comportamentale. La rassegna delle dieci lezioni sull'addiction ai SNS sostiene che gli individui possono sviluppare una dipendenza dall'uso dei siti di social networking, con sintomi e conseguenze tradizionalmente associati alle dipendenze da sostanze (Kuss & Griffiths, 2017). Il quadro deriva dal modello biopsicosociale delle dipendenze comportamentali, che individua sintomi quali mood modification, salience, tolerance e withdrawal (Bányai et al., 2017, p. 2).

La terminologia resta però frammentata. In letteratura coesistono etichette diverse – Facebook dependence, social networking addiction, Twitter addiction, Social Media Disorder – con differenti proposte diagnostiche (Bányai et al., 2017, p. 2). Nella quinta edizione del DSM-5 il solo Internet Gaming Disorder è stato incluso nella Sezione 3, senza un disturbo dedicato all'uso dei social (Bányai et al., 2017, p. 2).

La prevalenza è stimabile con strumenti validati. In un campione nazionalmente rappresentativo di 5.961 adolescenti ungheresi dell'indagine ESPAD, la Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) a 6 item e la latent profile analysis collocano il 4,5% nel gruppo a rischio (Bányai et al., 2017, p. 1). La BSMAS mostra proprietà psicometriche appropriate e viene giudicata uno strumento valido per identificare i segni di uso rischioso tra gli adolescenti (Bányai et al., 2017, p. 10).

Il profilo a rischio è caratterizzato da correlati psicopatologici. Lo stesso gruppo riporta bassa autostima, alti livelli di sintomi depressivi ed elevato uso dei social (Bányai et al., 2017, p. 1). La FoMO rientra tra le componenti dell'addiction ai SNS, insieme alla smartphone addiction e alla nomophobia (Kuss & Griffiths, 2017). Il perceived need to be online può tradursi in uso compulsivo dei SNS (Kuss & Griffiths, 2017).

Il meccanismo che collega uso normale e malessere passa attraverso la componente addittiva. In uno studio su 1.302 studenti di scuola superiore cinesi (M età = 16,03), la short-form video addiction opera come mediatore, in una catena con la need gratification, tra l'uso dei video brevi e la depressione (Zhu et al., 2024). Lo studio rileva un'associazione diretta tra uso e depressione e, insieme, il ruolo mediante del comportamento addittivo, senza differenze di genere nel modello (Zhu et al., 2024).

Il disegno cross-sezionale dello studio ungherese non permette di stabilire se la bassa autostima preceda o segua l'uso problematico (Bányai et al., 2017, p. 3). La misura BSMAS, inoltre, riguarda il solo social networking, ma i partecipanti potrebbero avervi incluso attività non-networking come gaming o gambling (Bányai et al., 2017, p. 10).

La convergenza tra i tre studi indica che una minoranza di adolescenti – il 4,5% nel campione ESPAD (Bányai et al., 2017, p. 1) – sviluppa un uso problematico affidabilmente misurabile, associato a bassa autostima e sintomi depressivi, in cui l'addiction media il passaggio dall'uso ordinario al distress (Zhu et al., 2024).

3.3 Qualità del sonno negli adolescenti

La revisione narrativa di Sztenc et al. (2026) sintetizza studi peer-reviewed pubblicati tra il 2016 e il 2026, individuati su PubMed e Google Scholar, sull'impatto dell'uso serale dei social media sul sonno adolescenziale (Sztenc et al., 2026, p. 3). L'uso serale si associa in modo coerente a ritardo dell'addormentamento, minore durata e peggiore qualità del sonno attraverso tre vie interconnesse: comportamentale, psicologica e fisiologica (Sztenc et al., 2026, p. 3).

Sul piano comportamentale, il controllo abituale del dispositivo e la fear of missing out spostano il sonno, mentre l'esposizione a contenuti emotivamente salienti ne ritarda l'inizio (Sztenc et al., 2026, p. 3). Uno studio cross-sezionale su 11.872 adolescenti di 13-15 anni (Scott et al., 2019) rileva che un uso elevato dei social si correla a orari di coricamento più tardivi, durata più breve e peggiore qualità (Sztenc et al., 2026, p. 5). Chi supera le cinque ore giornaliere riferisce maggiore difficoltà ad addormentarsi e a riprendere sonno dopo i risvegli notturni (Sztenc et al., 2026, p. 5).

L'engagement notturno costituisce un fattore aggiuntivo: notifiche e connettività costante aumentano la probabilità di uso prolungato e di ritardo dell'addormentamento (Fiore et al., 2025) (Sztenc et al., 2026, p. 5). Le notifiche notturne interrompono il sonno e inducono arousal cognitivo ed emotivo, compromettendo la continuità del sonno (Sztenc et al., 2026, p. 5).

Sul piano psicologico, il contenuto stimolante ed emotivamente saliente incrementa la vigilanza e interferisce con l'addormentamento (Scott et al., 2019) (Sztenc et al., 2026, p. 7). La privazione di sonno e gli esiti negativi di salute mentale – depressione e ansia – si rinforzano reciprocamente in una relazione bidirezionale (Liew & Aung, 2021; Tordjman et al., 2017), e i pattern problematici di uso risultano più fortemente associati a questi esiti rispetto all'uso generale (Sztenc et al., 2026, p. 7).

Sul piano fisiologico, l'esposizione alla luce blu altera la secrezione di melatonina e il timing circadiano (Sztenc et al., 2026, p. 3). Il disallineamento tra ritmi circadiani endogeni e obblighi sociali configura il fenomeno del «social jet lag» (Roenneberg & Merrow, 2005) (Sztenc et al., 2026, p. 4).

I tre meccanismi non operano in modo indipendente: formano un ciclo di rinforzo in cui i pattern comportamentali aumentano l'esposizione a contenuti stimolanti e luce blu, che a loro volta accrescono l'arousal e disturbano la regolazione fisiologica del sonno, con esito in fatica diurna e funzionamento compromesso (Sztenc et al., 2026, p. 7).

I tratti individuali modulano questo quadro. Lo studio di (Lin & Chung, 2021) esamina i ruoli distintivi del cronotipo e del tratto di autocontrollo nel predire la qualità del sonno, e la mediazione delle componenti dell'igiene del sonno e dell'uso mediatico serale nelle relazioni tra cronotipo, autocontrollo e qualità del sonno (Lin & Chung, 2021). L'uso serale dei media si colloca dunque come via mediante attraverso cui i tratti disposizionali si traducono in peggiore qualità del sonno.

Gran parte delle evidenze sintetizzate poggia su dati auto-riferiti e disegni cross-sezionali, che limitano le inferenze causali sulle vie descritte (Sztenc et al., 2026, p. 7).

4. Regolazione emotiva, fattori protettivi e interventi di prevenzione a scuola e in famiglia

4.1 Regolazione emotiva in adolescenza

La regolazione emotiva si colloca come predittore diretto del benessere soggettivo in età evolutiva. Uno studio su 132 bambini italiani tra 8 e 11 anni, condotto entro la cornice della Positive Psychology, esamina il benessere soggettivo nelle sue componenti edonica ed eudaimonica (Businaro, 2011). L'analisi delle associazioni verbali collega il benessere a famiglia, scuola, amicizie, sport e all'emozione della felicità (Businaro, 2011). L'esperienza emotiva positiva emerge quindi come nucleo della soddisfazione di vita già nell'infanzia, prima dell'esposizione intensiva ai social.

La componente relazionale del benessere si differenzia per genere: le femmine descrivono il benessere in termini socio-emotivi, i maschi in termini di gioco (Businaro, 2011). Questa centralità dell'elaborazione emotiva anticipa il ruolo che le strategie di regolazione assumono nell'adolescenza, quando l'uso dei social diventa pervasivo.

Il legame tra maturazione della regolazione emotiva e sviluppo neurale è documentato: i cambiamenti nella corteccia prefrontale e nel sistema limbico sono critici per la maturazione delle funzioni esecutive e della regolazione emotiva (Sztenc et al., 2026, p. 3). Il sonno REM sostiene specificamente l'elaborazione emotiva (Sztenc et al., 2026, p. 3). La disregolazione del sonno indotta dall'uso serale dei social interferisce dunque con lo stesso substrato che supporta la regolazione affettiva.

Sul versante dei contesti d'uso disregolanti, i meccanismi psicologici che collegano l'uso serale al disturbo del sonno includono l'arousal emotivo e cognitivo accresciuto, il confronto sociale e la ricerca di validazione (Sztenc et al., 2026, p. 6). L'uso passivo si configura come modalità che alimenta arousal e distress anziché regolarli.

La gratificazione disregolata dei bisogni fornisce il meccanismo mediante. In uno studio su 1.302 studenti di scuola superiore cinesi (M età = 16,03), la need gratification opera in una catena mediatrice, con la short-form video addiction, tra l'uso dei video brevi e la depressione (Zhu et al., 2024). Lo studio rileva un'associazione diretta tra uso e depressione senza differenze di genere nel modello (Zhu et al., 2024). La gratificazione del bisogno, quando avviene attraverso un uso compulsivo, amplifica il distress invece di soddisfare la regolazione emotiva.

Il quadro indica che la regolazione emotiva è il meccanismo bersaglio degli interventi: la corteccia prefrontale in maturazione è plasmabile (Sztenc et al., 2026, p. 3), e la gratificazione dei bisogni è modificabile nel suo esito depressivo quando non passa per l'addiction (Zhu et al., 2024). Le evidenze primarie qui disponibili non misurano direttamente la rivalutazione cognitiva né la mediazione della solitudine nell'uso passivo, che restano non documentate da questi estratti.

4.2 Fattori protettivi

Il supporto sociale opera come meccanismo di mediazione tra risorse psicologiche individuali e resilienza. Uno studio cross-sezionale del 2014-2015 su adolescenti thailandesi (età 12-24 anni) in trattamento per disturbo da uso di amfetamine ha esaminato il supporto sociale come mediatore tra autostima, capacità di coping e resilienza all'uso di sostanze (Uthis et al., 2025). L'autostima mostra un effetto totale significativo sulla resilienza ($\beta = 0,2609$, $P < 0,001$), parzialmente mediato dal supporto familiare ($\beta = 0,1232$, $P = 0,002$), ma non dal supporto degli amici ($\beta = -0,0005$, $P = 0,977$) (Uthis et al., 2025).

La distinzione tra fonti di supporto è dunque empirica, non solo concettuale. Il supporto familiare veicola l'effetto dell'autostima sulla resilienza, mentre il supporto amicale non lo fa; l'autostima, del resto, non presenta relazione significativa con il supporto degli amici ($\beta = -0,0016$, $P = 0,976$) (Uthis et al., 2025). Le capacità di coping incidono sulla resilienza ($\beta = 0,5717$, $P < 0,001$) con mediazione sia del supporto familiare sia di quello amicale (Uthis et al., 2025). Il coping, a differenza dell'autostima, mobilita entrambe le reti di supporto.

Resilienza e supporto sociale percepito operano come fattori protettivi anche di fronte alla vittimizzazione. Uno studio su 790 studenti universitari (71% femmine, età 18-31 anni), fondato sullo Schematic Appraisals Model of Suicide, ha rilevato che la resilienza media l'associazione tra polivittimizzazione e pensieri o comportamenti suicidari (Lee, 2024). Livelli più alti di resilienza rendono i giovani polivittimizzati meno soggetti a pensieri suicidari (Lee, 2024). Il supporto sociale percepito agisce come moderatore: chi subisce polivittimizzazione e riceve supporto sociale ha minore probabilità di pensieri suicidari (Lee, 2024). Per i polivittimizzati, quindi, resilienza e supporto sociale percepito fungono entrambi da fattori protettivi (Lee, 2024).

Le due funzioni sono distinte: nel modello la resilienza media, il supporto sociale modera. Ciò indica ruoli complementari, non sovrapponibili, tra risorsa individuale e risorsa relazionale nel tamponare gli esiti negativi.

Il divario tra supporto online e offline circoscrive la portata protettiva delle risorse digitali. Gli amici online possono costituire una fonte importante di supporto sociale, ma il supporto in presenza risulta più protettivo contro la vittimizzazione; il supporto online non ha ridotto la probabilità di alcun tipo di vittimizzazione valutata (Khalaf et al., 2023, p. 6). L'uso dei social media si associa anche a maggiore popolarità e supporto sociale percepito (Khalaf et al., 2023, p. 4).

I campioni sono selettivi – adolescenti thailandesi in trattamento e studenti universitari statunitensi – e nessuno riguarda direttamente l'esposizione ai social media in coorti adolescenziali generali, il che limita la trasferibilità dei parametri di mediazione a contesti d'uso ordinario delle piattaforme.

4.3 Interventi di prevenzione a scuola

La prevenzione scolastica dei rischi legati ai social media si struttura secondo un modello a molteplici livelli. Il

contributo di (Menesini et al., 2019) propone per il cyberbullismo un modello che articola promozione della salute, prevenzione differenziata in universale, selettiva e indicata, trattamento e riabilitazione (Menesini et al., 2019). Questa architettura è trasferibile ai rischi dell'uso dei social media, che condividono con il cyberbullismo l'ambiente digitale e la fascia evolutiva bersaglio.

Il dato centrale del modello riguarda l'efficacia differenziale dei livelli. Gli interventi di prevenzione universale risultano efficaci solo in alcuni casi e solo per alcuni bambini e adolescenti, mentre le situazioni di maggior rischio richiedono interventi più consistenti e continuativi nel tempo, con componenti specifiche (Menesini et al., 2019). La prevenzione universale, da sola, non copre quindi l'intero spettro del rischio.

Questa limitazione dell'universale definisce il bisogno di un target selettivo e indicato. Lo studio ungherese su un campione nazionalmente rappresentativo di 5.961 adolescenti individua un gruppo a rischio pari al 4,5%, con bassa autostima, alti sintomi depressivi ed elevato uso dei social (Bányai et al., 2017, p. 1). Gli autori concludono che gli adolescenti a rischio di uso problematico dovrebbero essere bersaglio di programmi scolastici di prevenzione e intervento (Bányai et al., 2017, p. 1).

Lo strumento operativo per identificare questo target esiste. La BSMAS è uno strumento psicometricamente valido per riconoscere i segni dell'uso rischioso tra gli adolescenti, particolarmente utile in ambiente scolastico per individuare chi è a rischio (Bányai et al., 2017, p. 10). Il cut-off suggerito, con adeguate sensibilità e specificità, è di 19 punti (Bányai et al., 2017, p. 9). Nel gruppo a rischio la componente di astinenza presenta il punteggio più alto, e va perciò evidenziata nei programmi scolastici (Bányai et al., 2017, p. 9).

La componente universale trova invece la sua base nell'alfabetizzazione mediatica e transmediale. Il progetto H2020 Transmedia Literacy, condotto in 8 paesi tra il 2015 e il 2018, ha prodotto una mappa delle competenze transmediali e un Teacher's Kit per integrarle in classe (Scolari, 2019, p. 1); p. 2. L'approccio ribalta la domanda: non «cosa i giovani devono sapere sui media», ma «cosa fanno i giovani con i media digitali e come apprendono a farlo» (Scolari, 2019, p. 2). Recupera così a scuola le competenze e le pratiche sviluppate dai giovani negli ambienti di apprendimento informale (Scolari, 2019, p. 1).

L'approccio della media education più attuale si fonda su nozioni quali consapevolezza critica e partecipazione democratica (Scolari, 2019, p. 3), distinguendosi dalla percepita necessità di «proteggere» i giovani dai media propria delle tradizioni meno consolidate (Scolari, 2019, p. 3). Per gli adolescenti già identificati come a rischio, gli interventi indicati includono software di controllo dei contenuti, counseling e terapia cognitivo-comportamentale (Bányai et al., 2017, p. 10).

Il modello di (Menesini et al., 2019) deriva dalla letteratura sul cyberbullismo, non da studi sull'uso dei social media in senso stretto, e questo limita la trasferibilità diretta dei parametri di efficacia dei singoli livelli.

4.4 Interventi di prevenzione in famiglia

La distinzione tra mediazione attiva e restrittiva costituisce l'asse dell'evidenza sperimentale disponibile. Uno studio su 356 adolescenti statunitensi appartenenti a minoranze razziali/etniche – 178 giovani neri e 178 latini, con età media di 16,01 anni – esamina il ruolo moderatore della mediazione genitoriale sugli effetti dell'uso dei social media (Thomas et al., 2026). Il disegno distingue tre dimensioni dell'uso (numero di account, tempo online, attività svolte) e valuta il funzionamento giovanile su tre piani: ill-being sociale, ill-being emotivo e benessere accademico (Thomas et al., 2026).

Il risultato centrale è differenziale. La mediazione attiva tampona gli impatti negativi in modo più efficace della mediazione restrittiva (Thomas et al., 2026). Lo studio documenta che l'uso dei social media ha effetti sia benefici sia dannosi, e che il coinvolgimento genitoriale è critico nel mitigare i rischi potenziali (Thomas et al., 2026). La restrizione, da sola, non emerge come la leva protettiva principale: è la qualità dell'accompagnamento adulto, non il solo controllo del tempo, a discriminare gli esiti.

Il campione riguarda adolescenti di minoranze etniche negli Stati Uniti, e questo limita la trasferibilità diretta dei parametri a contesti europei generali (Thomas et al., 2026).

Sul versante degli strumenti di supporto alla genitorialità, il progetto «Genitori In Corso», promosso dall'IRCCS E. Medea – Associazione La Nostra Famiglia con il sostegno di Fondazione Cariplo, offre un modello operativo documentato (Busti & Colombo, 2026, p. 1). Il progetto sostiene le famiglie nell'educazione digitale attraverso una piattaforma online con

contenuti psicoeducativi, strumenti personalizzati e supporto specialistico (Busti & Colombo, 2026, p. 1). I risultati mostrano un buon coinvolgimento dei genitori e confermano l'importanza di costruire reti territoriali integrate per un uso consapevole delle tecnologie (Busti & Colombo, 2026, p. 1).

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalle recenti linee guida della Società Italiana di Pediatria (SIP, 2025), che sottolineano l'importanza di regole condivise, supervisione adulta e collaborazione tra famiglia, scuola e pediatri (Busti & Colombo, 2026, p. 1). La revisione sistematica della Commissione Dipendenze Digitali della SIP rileva un impatto dell'uso non regolato su più aree, tra cui sonno e ritmi circadiani, benessere psicologico e adattamento sociale, cyberviolenza e rischi relazionali (Busti & Colombo, 2026, p. 1). Le raccomandazioni SIP si propongono come regole semplici, comprensibili e calibrate sull'età del bambino (Busti & Colombo, 2026, p. 1).

La collaborazione integrata è indicata come direzione di sviluppo prioritaria. Il progetto individua nei pediatri di famiglia i primi interlocutori dei genitori e precoci intercettatori dei loro bisogni, e auspica il potenziamento delle sinergie con gli enti del Terzo Settore per interventi accessibili, coordinati e sostenibili (Busti & Colombo, 2026, p. 3). L'innovazione nel welfare familiare è orientata verso una personalizzazione capace di rimodulare l'offerta psicoeducativa in tempo reale sulla base del carico emotivo rilevato nei genitori durante le interazioni di cura (Busti & Colombo, 2026, p. 3).

L'evidenza convergente indica dunque che la mediazione attiva protegge più della sola restrizione (Thomas et al., 2026), e che il suo esercizio è sostenibile solo se supportato da strumenti psicoeducativi strutturati e da reti integrate famiglia-scuola-pediatri secondo il modello SIP (Busti & Colombo, 2026, p. 1).

5. Discussione

Dall'integrazione dei quattro capitoli emerge un quadro in cui la relazione tra uso dei social media e salute mentale adolescenziale non è diretta né uniforme, ma passa attraverso fattori intervenienti. L'umbrella review condotta secondo le linee guida PRIOR, che ha selezionato 24 articoli sui 1470 titoli sottoposti a screening dopo valutazione qualitativa AMSTAR 2, individua tre classi di fattori: le caratteristiche demografiche e psico-sociali individuali, l'uso individuale dei social media, e il contenuto e il design delle piattaforme (Sala et al., 2024). Questa tripartizione ricompone i meccanismi sviluppati nei capitoli precedenti: il confronto sociale e la validazione tramite like operano al livello del design e del contenuto, la FoMO e l'uso problematico al livello dell'uso individuale, la regolazione emotiva e l'autostima al livello delle caratteristiche disposizionali.

La convergenza sui fattori intervenienti spiega perché gli effetti medi mascherino una forte variabilità. L'auto-confronto con influencer, e non il tempo trascorso su Instagram, discrimina l'impatto sull'immagine corporea (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 1), mentre nel gruppo a rischio ungherese la bassa autostima si associa al maggior tempo online in un disegno che non stabilisce la direzione causale (Bányai et al., 2017, p. 3); p. 9. Gli effetti sono quindi condizionali: dipendono da chi usa la piattaforma, come la usa e con quali contenuti interagisce.

Sul piano clinico e dello sviluppo, questa condizionalità sposta il bersaglio dall'esposizione tout court ai processi mediatori e moderatori. La regolazione emotiva emerge come meccanismo bersaglio modificabile, coerente con la plasticità della corteccia prefrontale in maturazione (Sztenc et al., 2026, p. 3). La prevenzione efficace risulta pertanto multilivello: media education orientata alla consapevolezza critica a scuola (Scolari, 2019, p. 3), mediazione attiva più protettiva della sola restrizione in famiglia (Thomas et al., 2026), e reti integrate famiglia-scuola-pediatri secondo il modello SIP (Busti & Colombo, 2026, p. 1).

L'umbrella review avanza però un argomento che eccede il livello individuale: attribuire il carico dell'uso responsabile alle sole scelte individuali rende più difficile un cambiamento a livello di popolazione, mentre l'adozione di principi di design responsabile da parte delle piattaforme contribuirebbe a un mutamento sociale (Sala et al., 2024). Il dato sperimentale sul disclaimer, che mitiga l'impatto dei like sull'autoconsapevolezza corporea (Gesto, 2025), corrobora empiricamente questa tesi: l'interfaccia non è neutrale e la sua modifica altera l'esito. Da qui la rilevanza delle cornici regolatorie emergenti come il Digital Services Act dell'UE, discusse come opportunità dalla stessa review (Sala et al., 2024).

Due limiti metodologici circoscrivono queste conclusioni. La prevalenza di disegni cross-sezionali e dati auto-riferiti limita le inferenze causali sulle vie descritte (Sztenc et al., 2026, p. 7). La limitazione nella raccolta dei dati delle piattaforme ostacola la ricerca sull'impatto reale dell'uso dei social media (Sala et al., 2024), impedendo di misurare direttamente ciò che i modelli teorici postulano. Un terzo limite riguarda la trasferibilità: gli studi sull'immagine

corporea su Instagram riguardano giovani donne e non documentano gli effetti sui maschi, così come i correlati della FoMO derivano da studenti universitari ed emerging adults, non da campioni adolescenziali specifici (Thomas & George, 2025). Le stime di associazione restano quindi condizionate al piano-piattaforma e alla popolazione esaminata, e non autorizzano generalizzazioni indifferenziate all'età evolutiva.

Conclusioni

La domanda su come e per chi i social media incidano sul benessere adolescenziale trova risposta in una relazione mediata e moderata, non in un effetto diretto e uniforme. La pervasività dell'uso è quasi universale: il 92% dei teenager si connette ogni giorno e il 24% dichiara di stare online quasi costantemente (Scolari, 2019, p. 4). Su questa base, però, l'esito sul benessere dipende dai meccanismi che si attivano, non dal tempo d'uso in sé.

Il confronto sociale ascendente verso bersagli percepiti come irraggiungibili genera inadeguatezza, vergogna e stati depressivi (Festinger, 1954) (Moreno-Padilla et al., 2025, p. 2). La fear of missing out, ansia di esclusione da esperienze gratificanti emersa nel 2004, amplifica il distress e si intreccia con l'uso problematico (Chakrabarti, 2024). L'uso serale si associa in modo coerente a ritardo dell'addormentamento, minore durata e peggiore qualità del sonno attraverso vie comportamentali, psicologiche e fisiologiche interconnesse (Sztenc et al., 2026, p. 3).

Sul versante protettivo, l'autostima esercita un effetto totale significativo sulla resilienza ($\beta = 0,2609$, $P < 0,001$), parzialmente mediato dal supporto familiare ($\beta = 0,1232$, $P = 0,002$) ma non da quello amicale ($\beta = -0,0005$, $P = 0,977$) (Uthis et al., 2025). La centralità dei mediatori e dei fattori familiari orienta le implicazioni verso interventi integrati che coinvolgano scuola e famiglia, piuttosto che verso la sola responsabilità individuale dell'adolescente.

Le direzioni future discendono dai limiti dell'evidenza disponibile. La sintesi degli studi 2016-2026 su sonno e uso serale è costruita su ricerche reperite in PubMed e Google Scholar e indica la necessità di disegni longitudinali ed esperimenti per chiarire la causalità (Sztenc et al., 2026, p. 3). Servono studi che valutino l'efficacia degli interventi integrati e i cambiamenti di responsible design, oltre alla responsabilità individuale.

Due limiti circoscrivono queste conclusioni. Diverse evidenze provengono da campioni cross-sezionali o da popolazioni specifiche, come adolescenti thailandesi in trattamento per uso di amfetamine (Uthis et al., 2025), il che riduce la trasferibilità agli adolescenti generali. Alcuni dati sulla diffusione risalgono a rilevazioni datate, con una gerarchia tra piattaforme oggi modificata (Scolari, 2019, p. 4).

Bibliografia

Aroldi, P., & Mascheroni, G. (2020). OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS ONLINE ALLA RICERCA SUL BENESSERE SOCIALE DEI GIOVANI UTENTI DELLA RETE. Media Education. <https://doi.org/10.36253/me-8842>

Arrivabene, E. (2019). Stile di vita e benessere psicofisico nei bambini della scuola primaria. Uno studio esplorativo. Archivio Istituzionale della Ricerca (Università Degli Studi Di Milano). https://doi.org/10.13130/arrivabene-elena_phd2019-03-05

Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., ... Demetrovics, Z. (2017). Problematic Social Media Use: Results from a Large-Scale Nationally Representative Adolescent Sample. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839>

Brogonzoli, L., Niolu, C., Valentini, L., & Iardino, R. (2026). Salute mentale e Brain-Mind Capital: dimensioni socioeconomiche e prospettive di intervento. Recenti Progressi in Medicina. <https://doi.org/10.1701/4729.47457>

Businaro, N. (2011). Il benessere soggettivo in bambini tra gli 8 e gli 11 anni. L'impatto dell'intelligenza, della regolazione e dell'esperienza emotiva sulla soddisfazione di vita. The subjective well-being in children aged 8-11. Impact of intelligence, emotional experience and regulation on life satisfaction. BOA (University of Milano-Bicocca)

Busti, S., & Colombo, P. (2026). Genitori In Corso: kit digitale a sostegno della genitorialità. Quaderni acp.

3,8

19

10,
12,
15

1,
18

7

<https://doi.org/10.53141/qacp.2026.225-227>

Chakrabarti, D. (2024). A Study on How Social Media FOMO (Fear of Missing Out) Impacts the Gen Z Audience.

Gesto, C. D. (2025). Influenze socioculturali, immagine corporea e chirurgia estetica.

Ho, S. C. E., & Fung, A. (2026). Adolescent Social Media Use Motives: A Five-Factor Scale Integrating Self-Determination and Uses and Gratifications.

Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., & Rifaey, A. A. (2023). The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.42990>

Kuss, D., & Griffiths, M. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>

Lee, J. M. (2024). Polyvictimization and suicidal ideations/behaviors among college students: Examining protective factors of resilience and social support. *Global Health Economics and Sustainability*. <https://doi.org/10.36922/ghes.3737>

Lin, S. Y., & Chung, K. K. H. (2021). Chronotype and trait self-control distinctively predicted subjective sleep quality via sleep hygiene behaviors and bedtime media use.

Menesini, E., Corbo, E., & Nocentini, A. (2019). LA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA. UN APPROCCIO A MOLTEPLICI LIVELLI. *Media Education*. <https://doi.org/10.36253/me-8841>

Moreno-Padilla, M., Delgado-Rodríguez, R., Moreno-Domínguez, S., & Cepeda-Benito, A. (2025). Self-comparison with influencers but not general Instagram use moderate upward and downward social comparisons to #fitspiration and #bodypositive images. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*. <https://doi.org/10.5817/cp2025-2-2>

Nerini, A. (2009). Influenza dei media, autostima e insoddisfazione corporea in un gruppo di preadolescenti maschi e femmine. *PSICOLOGIA DELLA SALUTE*. <https://doi.org/10.3280/pds2009-001005>

Sala, A., Porcaro, L., & Gómez, E. (2024). Social Media Use and adolescents' mental health and well-being: An umbrella review. *Computers in Human Behavior Reports*. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100404>

Scolari, C. (2019). Dalla alfabetizzazione mediatica all'alfabetizzazione transmediale. *DigitCult - Scientific Journal on Digital Cultures*. <https://doi.org/10.54103/2531-5994/31120>

Stefanile, C., Matera, C., Pisani, E., & Zambrini, I. (2009). Insoddisfazione corporea in adolescenza: influenze di fattori bio-psico-sociali. *PSICOLOGIA DELLA SALUTE*. <https://doi.org/10.3280/pds2009-002004>

Sztenc, N., Kamrowska, M., Świech, J., Apanasewicz, K., Kopacki, F., Szczebleska, W., ... Broniszewska, P. (2026). THE IMPACT OF NIGHTTIME SOCIAL MEDIA USE ON SLEEP QUALITY IN ADOLESCENTS: A NARRATIVE REVIEW. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*. [https://doi.org/10.31435/ijitss.2\(50\).2026.5508](https://doi.org/10.31435/ijitss.2(50).2026.5508)

Taylor, Z., Yankouskaya, A., & Panourgia, C. (2023). Social media use, loneliness and psychological distress in emerging adults. *Behaviour & Information Technology*. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2023.2209797>

Thomas, A., Chen, H. Y., & Jing, M. (2026). Parenting in the Digital Age: The Role of Parental Mediation in Youth Social Media Use and Functioning.

Thomas, D. R., & George, M. A. (2025). Fear of Missing Out (FOMO), Emotional Distress, and Problematic Social Media Use (PSMU) among University Students.

Tiggemann, M., & Polivy, J. (2010). Upward and Downward: Social Comparison Processing of Thin Idealized Media Images. *Psychology of Women Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01581.x>

Uthis, P., Mangrio, F. A., & Rojnawee, S. (2025). Investigating the Potential Mediating Role of Social Support in the Relationship between Psychological Protective Factors and Resilience to Amphetamine Use among Thai Adolescents. *Asian Journal of Social Health and Behavior*. https://doi.org/10.4103/shb.shb_377_24





Valkenburg, P. M., Koutamanis, M., & Vossen, H. G. (2017). The concurrent and longitudinal relationships between adolescents' use of social network sites and their social self-esteem. *Computers in Human Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.008>

Zhu, C., Jiang, Y., Lei, H., Wang, H., & Zhang, C. (2024). The relationship between short-form video use and depression among Chinese adolescents: Examining the mediating roles of need gratification and short-form video addiction. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30346>